

ANALISIS LAMA WAKTU TUNGGU PELAYANAN PASIEN
RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT “X”

AURRELIA EKA AZZAHRA
P17410223074

Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Menurut UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (UU No. 44, 2009). Departemen Kesehatan RI telah menetapkan waktu tunggu melalui standar pelayanan minimal. Menurut Depkes RI (2008) waktu tunggu adalah lama waktu pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari tempat pendaftaran sampai masuk keruang pemeriksaan dokter. Berdasar Kemenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 standar pelayanan minimal di rawat jalan ialah kurang atau sama dengan 60 menit.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/11/1987, yang dimaksud pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang (pasien) yang masuk rumah sakit/puskesmas/klinik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap. Dari sisi pelayanan, rawat jalan diberikan di unit pelaksanaan fungsional rawat jalan yang terdiri dari poliklinik umum dan poliklinik spesialis serta unit gawat darurat. Pendaftaran pasien merupakan prosedur awal yang harus dilakukan pasien sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan.

Sebelum melakukan pendaftaran pasien diarahkan untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu yang kemudian petugas akan memanggil pasien sesuai nomor urut antrian tersebut untuk dilakukan proses pendaftaran. Hal tersebut yang menyebabkan pasien harus menunggu sebelum diberikan pelayanan kesehatan. Setiap pelayanan yang diberikan kepada pasien diharapkan dapat sesuai dengan standar pelayanan minimal yaitu mengenai batas-batas tertentu dalam mengukur suatu kinerja. Lama waktu tunggu pasien sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurut MENKES/SK II/2008 yang menyebutkan bahwa pelayanan pendaftaran waktu pelayanan yaitu ≤ 10 menit. Dari uraian diatas diketahui bahwa hasil dari pemecahan masalah mengenai lama waktu tunggu pasien diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam penelitian ini akan membahas permasalahan terkait analisis lama waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan yang dilakukan di Rumah Sakit “X”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis lama waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan di Rumah Sakit “X” ?

1.3 Tujuan

a. Tujuan Umum

1. Mengetahui gambaran lama waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi lama waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan
2. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan mutu waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan

1.4 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai alternatif untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam pengembangan ilmu khususnya mengenai lama waktu tunggu pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit “X”.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Petugas Rekam Medis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk petugas rekam medis yang khususnya pada petugas loket pendaftaran agar dapat ditingkatkan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

2. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan khususnya mengenai lama waktu tunggu pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit “X” dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar minimal pelayanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Menurut WHO (World Health Organization), definisi rumah sakit adalah integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (Komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (Preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat peneliti medik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut American Hospital Association (1974) dalam Azrul Azwar (1996), rumah sakit adalah suatu alat organisasi yang terdiri dari tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

3. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan.
5. Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan.

2.1.3 Pengertian Waktu Tunggu

Waktu tunggu telah ditetapkan secara standar oleh World Health Organization. Menurut WHO waktu tunggu adalah lamanya waktu pasien berobat di unit pelayanan kesehatan sebelum dilayani untuk konsultasi dan pengobatan (Ferry Dwi & Zulfikar, 2022). Waktu tunggu mengacu pada waktu seorang pasien menunggu di klinik sebelum dilihat oleh salah satu staf medis klinik (Nguyen et al., 2018). Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, (2022) waktu tunggu adalah dimulai pasien mendaftar sampai dipanggil untuk dilayani oleh dokter. Jadi waktu tunggu adalah waktu yang digunakan pasien mulai dari pasien datang sampai mendapatkan pelayanan tenaga kesehatan. rumah sakit di Indonesia telah mempunyai standar waktu tunggu. Standar waktu tunggu merupakan waktu maksimal yang ditetapkan seorang pasien untuk menunggu layanan. Menurut Menteri Kesehatan RI, (2022) standar waktu tunggu rawat jalan adalah maksimum 60 menit. Walaupun standar waktu tunggu ini sudah ditetapkan namun masih banyak rumah sakit yang lama waktu tunggu diatas nilai standar yang ditetapkan WHO dan Depkes.

2.1.4 Pelayanan Rawat Jalan

Menurut Permenkes No. 66/Menkes/II/1987 adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. Rawat jalan bertujuan untuk mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal.

Rawat jalan adalah jenis pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. Pelayanan ini tidak hanya diberikan di rumah sakit atau klinik, melainkan juga di rumah pasien (home care) dan rumah perawatan (nursing homes). Pelayanan rawat jalan melakukan upaya kesehatan

dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Namun, tugas instalasi rawat jalan dalam memberikan pelayanan dan penunjang medik tidak dapat dibatasi dengan pendekatan tersebut, tetapi dengan pelayanan kesehatan terbaik yang memiliki contact personal cukup tinggi. Diharapkan pelayanan ini dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Mutu pelayanan unit rawat jalan dapat memberikan persepsi tentang kualitas fasilitas kesehatan secara menyeluruh. Sebab, indikator utama untuk mengetahui mutu pelayanan rumah sakit adalah dari kepuasan pasien itu sendiri. Dikutip dari buku *Loyalitas Pasien* susunan Yolanda Anastasia Sihombing (2022), prinsip-prinsip pelayanan rawat jalan yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Fasilitas fisik rumah sakit yang memadai.
2. Jam praktek yang tepat, terdapat pelayanan 24 jam dan sistem rujukan yang baik.
3. Penjadwalan kunjungan efisien untuk memperpendek waktu tunggu.
4. Tarif yang terjangkau oleh sasaran.
5. Kualitas pelayanan oleh dokter dan perawat dilakukan dengan ramah, penuh perhatian terhadap kebutuhan pasien dan perasaannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar minimal rawat jalan adalah sebagai berikut:

1. Dokter yang melayani bagian Poliklinik Spesialis harus terdiri dari 100 dokter spesialis.
2. Rumah sakit setidaknya menyediakan pelayanan klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, dan klinik bedah.
3. Jam buka pelayanan adalah pukul 08.00-13.00 setiap hari kerja, kecuali hari Jumat pukul 08.00-11.00.
4. Waktu tunggu untuk rawat jalan tidak lebih dari 60 menit.
5. Kepuasan pelanggan dijamin lebih dari 90%. Ketersediaan pelayanan rawat jalan di RS Jiwa.

Berdasarkan Depkes RI Tahun (2006:46), prosedur penerimaan pasien rawat jalan yaitu :

a. Menyiapkan formulir dan catatan serta nomor rekam medis yang diperlukan untuk pelayanan. Formulir dan catatan yang perlu disiapkan adalah :

- 1) Formulir dokumen rekam medis (DRM) rawat jalan baru yang telah diberi nomor rekam medis
- 2) Kartu Indeks Utama Pasien (KIUP)
- 3) Kartu Identitas Berobat (KIB)
- 4) Tracer
- 5) Karcis pendaftaran pasien

b. Alur dan prosedur pendaftaran pasien rawat jalan sebagai berikut :

- Pelayanan Pasien baru

- 1) Ucapkan salam kepada pasien atau keluarga pasien.
- 2) Tanyakan kepada pasien sudah pernah periksa di RS Muhammadiyah Selogiri atau belum.
- 3) Jika belum pernah, minta KTP/ Identitas pasien yang masih berlaku.
- 4) Input data sosial pasien ke komputer.
- 5) Cetak kartu identitas berobat (KIB) pasien, label nama, dan dokumen rekam medis.
- 6) KIB diserahkan kepada pasien dan diarahkan keruang tunggu rawat jalan serta poliklinik yang dituju.
- 7) Ucapkan terima kasih.
- 8) Tempelkan antrian pasien di berkas rekam medis, dan kirim dokumen rekam medis ke counter perawat poliklinik.

- Pelayanan Pasien lama

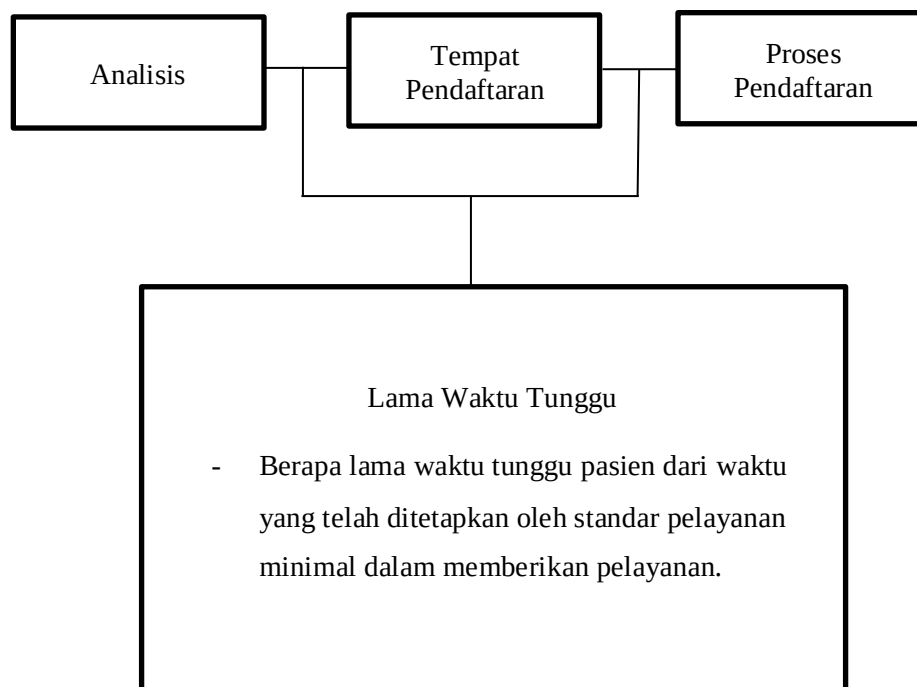
- 1) Ucapkan salam kepada pasien atau keluarga pasien.
- 2) Minta KIB pasien dan input nomor rekam medis.
- 3) Cetak label nama dan pemeriksaan dokter.
- 4) Berikan arahan kepada pasien untuk menunggu di ruang tunggu rawat jalan serta poliklinik yang dituju.
- 5) Ucapkan terima kasih.
- 6) Cetak label nama.
- 7) Tempelkan antrian pasien di berkas rekam medis, dan kirim dokumen rekam medis ke counter perawat poliklinik.

2.1.5 Pengertian Rekam Medis

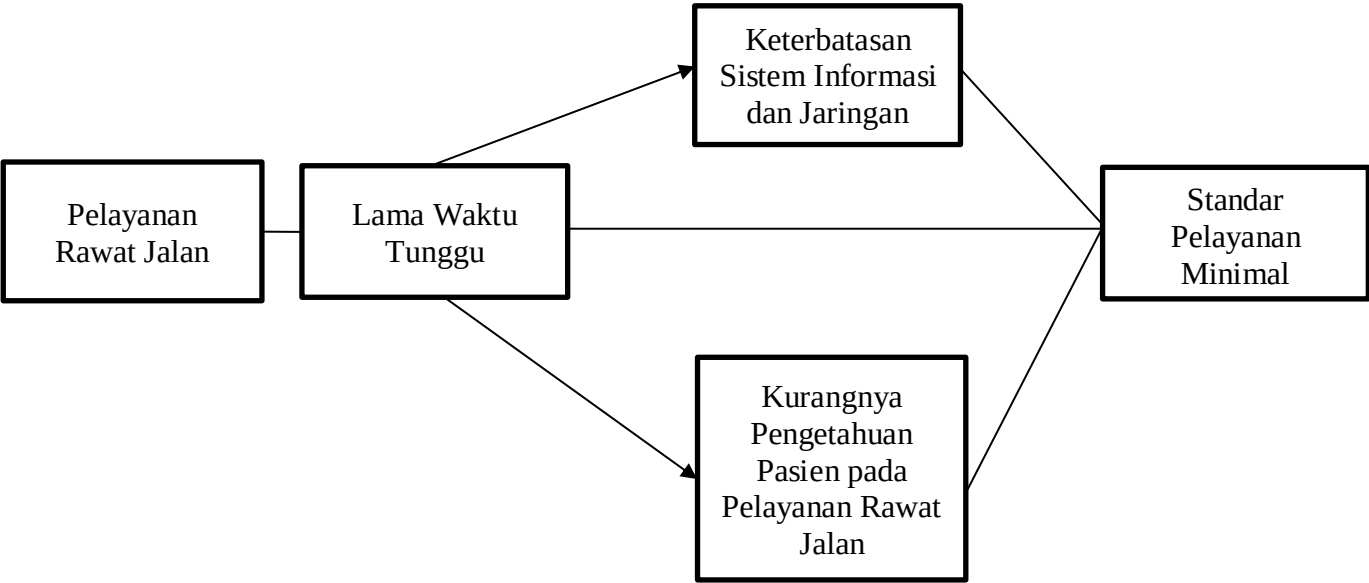
Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengelolaan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien pada sarana dan pelayanan kesehatan, (Depkes RI, 2006). Rekam medis merupakan sumber informasi kesehatan dan salah satu pendukung dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tatanan pelayanan kesehatan. Untuk menghasilkan informasi yang lengkap, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berkas rekam medis, (Savitri, 2011) .

Menurut PERMENKES RI Nomor 269 tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan berkas tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien. Rekam medis harus segera dibuat dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan (PERMENKES, 2008).

2.2 Kerangka Teori



2.3 Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis rancangan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara yaitu dengan melihat objek secara langsung dan melakukan tanya jawab kepada subjek yang dibutuhkan.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:68)

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek sampel yaitu lama waktu tunggu pelayanan pada pasien rawat jalan. Pengambilan data yang dilakukan yaitu terkait berapa lama pasien harus menunggu yang dimulai dari loket antrian sampai menerima pelayanan rawat jalan. Dari hasil tersebut kemudian akan di analisis untuk dapat diketahui apakah lama waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan sudah sesuai standar pelayanan minimal atau belum.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, sedangkan dalam arti luas populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah pasien yang akan melakukan pengobatan rawat jalan.

Sugiyono (2019), menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah serta karteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *Non-Probability Sampling* dengan teknik *Convenience Sampling*. *Convenience Sampling* adalah kumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan setuju bersedia memberikan informasi tersebut.

3.4 Instrumen dan Cara Pengumpulan Data

3.4.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah dipilih (Kristanto, 2018:66).

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan peneliti adalah metode observasi dan metode wawancara dengan menggunakan lembar observasi, pedoman wawancara, dan stopwatch.

3.4.2 Cara Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”.

2. Metode Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati setiap peristiwa yang berlangsung dan mencatatnya dengan menggunakan lembar observasi. Metode observasi ini menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi ataupun perilaku. Metode observasi pada penelitian ini dengan melakukan pengukuran waktu yang dilakukan untuk pengambilan data terkait seberapa lama pasien menghabiskan waktunya untuk melalui proses dari loket antri hingga pasien mendapatkan pelayanan atau dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.5.1 Teknik Pengolahan Data

Beberapa tahapan pengolahan setelah data dikumpulkan sebagai berikut:

1. Collecting yaitu mengumpulkan waktu tunggu pendaftaran pada pasien umum
2. Editing yaitu meneliti hasil pengumpulan data perhitungan waktu tunggu pasien umum

3. Tabulasi yaitu pengumpulan data yang dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam tabel
4. Penyajian data yaitu penggambaran hasil penelitian yang berbentuk narasi

3.5.2 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi kemudian data tersebut diolah menjadi hasil analisis untuk mengetahui faktor penyebab lama waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan pada pendaftaran rawat jalan.

3.6 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit “X” Kota Malang. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu mulai bulan Juni sampai akhir bulan Agustus 2024.

3.7 Tahapan Penelitian

Beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Pengajual judul laporan tugas akhir
2. Konsultasi dan ACC terkait judul laporan tugas akhir dengan dosen pembimbing
3. Studi penelitian awal

DAFTAR PUSTAKA

- Neti M. Bustani., A. Joy Rattu., & Josephine S. M. Saerang.,. (2015). *Analisis Lama Waktu Tunggu Pelayanan Pasien Rawat Jalan Di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Propinsi Sulawesi Utara*. eBiomedik, 3(3), 3–11.
- Nur Laeliah., & Heru Subekti. (2017). *Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan dengan Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan di Rawat Jalan RSUD Kabupaten Indramayu*. Jurnal Kesehatan Vokasional, 1(2), 1–11.
- Kemenkes. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Momen Amalia., & Era Pratiwi. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Di Instalasi Rawat Jalan Rsud Luwuk Banggai*. Jurnal Kesehatan Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan, 1(1), 1–9.
- Arifatun Nisaa., & Febri Sri Marden. (2018). *Gambaran Penerapan Alur Prosedur Pelayanan Dan Penyelenggaraan Rekam Medis Di Rs Pku Muhammadiyah Selogiri*. Jurnal Kesehatan Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan, 3(3), 1–14.